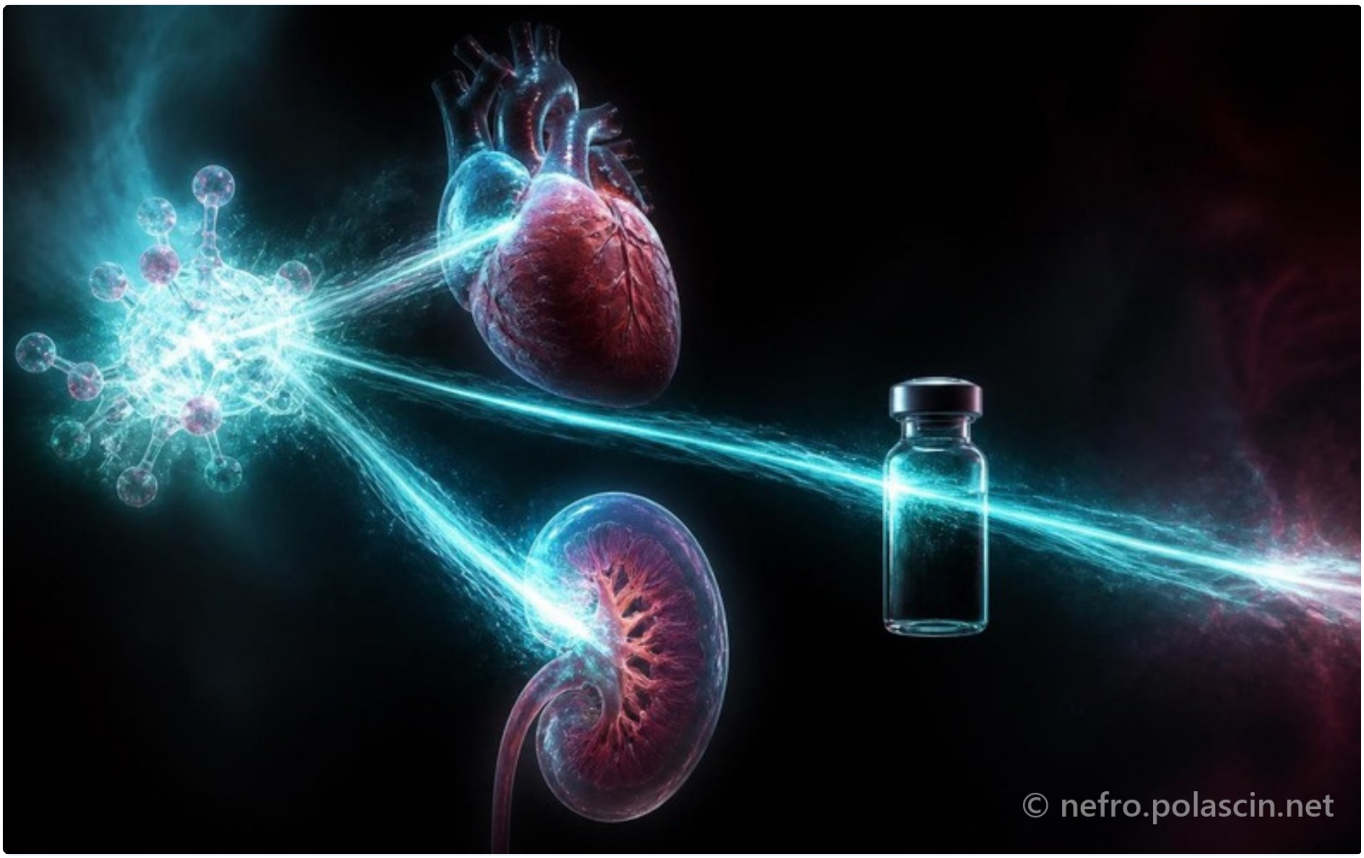
Kardiálne a renálne prínosy GLP-1 analógov sa môžu týkať aj diabetu 1. typu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Prínos, ktorý sa spájal s diabetom 2. typu, sa môže týkať aj pacientov na inzulíne.

V cielenej emulácii klinického skúšania sa ukázalo, že u ľudí s **diabetom 1. typu (T1D)** dodatočné užívanie **GLP-1 receptorových agonistov (GLP-1RAs)** bolo spojené s nižším rizikom **závažných kardiovaskulárnych udalostí (MACE)** aj **progresie do terminálneho zlyhania obličiek (ESKD)**. Súčasne sa nepozoroval nárast rizika **diabetickej ketoacidózy (DKA)** ani **ťažkej hypoglykémie**.

Prečo sa to riešilo

Autori zdôrazňujú, že ľudia s T1D majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych aj obličkových komplikácií, ale v kľúčových randomizovaných štúdiách, ktoré viedli k odporúčaniam u T2D, boli často **systematicky vylúčení**.

Podľa článku je testovanie GLP-1RAs v T1D v podobe klasických RCT náročné pre mladší vek populácie a nižšiu incidenciu udalostí.

Ako štúdia prebiehala (emulácia „target trial“)

Výskumníci navrhli štúdiu tak, aby čo najviac napodobnila randomizované skúšanie, a použili pozorovacie dáta z databázy **Optum Labs Data Warehouse**.

- Celkovo: **174 678** osôb s T1D
- GLP-1RA iniciovalo: **14 488**
- Medián sledovania: **38 mesiacov**

Hlavné výsledky

V „intention-to-treat“ analýze:

- **MACE:** 5-ročné riziko **4,3 %** u iniciátorov GLP-1RAs vs **5,0 %** u neiniciátorov (signifikantný rozdiel, približne **15 % relatívne** menej)
- **ESKD:** 5-ročné riziko **1,6 %** vs **1,9 %** (tiež signifikantné, približne **19 % relatívne** menej)

Účinok bol podľa autorov porovnateľný s veľkosťou zníženia rizika pozorovanou v štúdiách u T2D.

Sekundárne výsledky

- Zníženie hospitalizácií pre **srdcové zlyhávanie** približne o **18 %**
- Zníženie **major adverse liver events** približne o **28 %**
- Väčší podiel pacientov dosiahol **chudnutie** o 5 %, 10 % a 15 %

Bezpečnosť: DKA a hypoglykémia bez signálneho zvýšenia

U iniciátorov GLP-1RAs sa nepozorovalo zvýšenie hospitalizácií pre **DKA** ani pre **ťažkú hypoglykémiu**.

Autori to interpretujú v kontexte toho, že v reálnej praxi môže bezpečnosť podporovať širšie používanie technológií (napr. monitorovanie glykémie a modernejšie dávkovanie inzulínu), spolu so správnym výberom pacientov a dôsledným sledovaním.

Nežiaduce účinky

- **Gastrointestinálne príznaky** sa vyskytovali častejšie, ale rozdiel nebol štatisticky jednoznačne významný.
- Výsledky boli konzistentné naprieč podskupinami podľa veku (<45 vs ≥45 rokov) aj podľa východiskového A1c (<8 % vs ≥8 %).

Čo z toho vyvodiť prakticky

Tento výsledok je zaujímavý najmä preto, že u T1D ide o populáciu, ktorá bola dlho mimo veľkých RCT zameraných na kardiálne a renálne benefity GLP-1RAs.

Zároveň treba počítať s tým, že ide o **emuláciu target trial** na observačných dátach. Preto je namieste opatrnosť a pokračovanie overovania vo **veľkých randomizovaných skúšaniach** priamo v populácii T1D.

Zdroj: *Medscape. Kliknite sem.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kardialne-a-renalne-prinosy-glp-1-analogov-sa-mozu-tykat-aj-diabetu-1-typu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.